

総論

抗がん剤の分類と作用機序

分類・副作用の評価

1 薬剤の分類マップ

細胞障害性抗がん薬 DNA合成・細胞分裂を障害	アルキル化薬・白金製剤 シクロホスファミド シスプラチン オキサリプラチン 代謝拮抗薬 5-FU S-1 カペシタビン ゲムシタビン 微小管・トポ阻害薬ほか パクリタキセル イリノテカン ドキソルビシン
分子標的薬 がんに関連的な分子を狙う	小分子薬(経口) イマチニブ オシメルチニブ レンバチニブ 抗体薬 トラスツズマブ ペバシズマブ セツキシマブ 抗体薬物複合体(ADC) T-DXd T-DM1
免疫チェックポイント阻害薬 T細胞のブレーキを解除	抗PD-1抗体 ニボルマブ ベムプロリズマブ 抗PD-L1抗体 アテゾリズマブ デュルバルマブ 抗CTLA-4抗体 イビリムマブ
ホルモン療法 ホルモンの作用を遮断	乳がん タモキシフェン アナストロゾール レトロゾール フルベストラント 前立腺がん エンザルタミド アピラテロン リュープロレリン

☒ 経口薬(保険薬局で交付されることが多い) ☐ 注射薬

2 分類ごとの特徴と薬局での関わり

細胞障害性抗がん薬 標的 分裂の速い細胞(非選択的) 主な副作用 骨髄抑制・悪心嘔吐・脱毛・口内炎 起こる時期 投与後の決まった時期(nadir等) 保険薬局での主な関わり 経口薬の服用日管理、nadir期の電話フォロー	分子標的薬 標的 がんに関連的な分子 主な副作用 標的に応じた特有の副作用(皮疹・高血圧・下痢・ILD等) 起こる時期 服用開始から継続的に 保険薬局での主な関わり 相互作用・服用時点の確認、スキンケア指導	免疫チェックポイント阻害薬 標的 免疫のブレーキ(PD-1等) 主な副作用 irAE(皮膚・消化管・内分泌・肺など全身) 起こる時期 数週～数か月、終了後も 保険薬局での主な関わり 投与歴の把握、体調変化の聴取と受診勧奨	ホルモン療法 標的 ホルモン受容体・産生 主な副作用 ほてり・関節痛・骨密度低下・血栓症 起こる時期 年単位の長期服用 保険薬局での主な関わり アドヒアランス支援、骨・血栓の確認
--	---	--	---

3 副作用の特徴と発現時期

	投与日	1週	2週	1か月	3か月	1年～
● 過敏症(抗体薬・タキサン)	投与中～24時間					
● 悪心・嘔吐(細胞障害性)	～5日					
● 好中球減少(細胞障害性)		7～14日目				
● 皮疹・下痢(EGFR阻害薬)		服用1～2週から				
● 高血圧・蛋白尿(血管新生阻害薬)		開始数週				
● irAE(免疫チェックポイント阻害薬)			数週～数か月、終了後も			
● 間質性肺疾患			時期を問わず起こりうる			
● 関節痛・骨密度低下(ホルモン療法)					数か月～年単位	

☒ 重篤・特に注意 ☐ その他

押さえておきたいポイント

- 抗がん剤は4分類(細胞障害性・分子標的・ICI・ホルモン)。分類ごとに副作用の種類も時期も異なる
- 副作用はCTCAEのGradeで評価し、Gradeに応じてセルフケア支援・処方医への連絡・受診勧奨を判断
- 病院はレジメン監査と投与、薬局は経口薬の管理と自宅での経過確認。情報共有が安全な治療の鍵